

약제 영양급여의 적정성 평가 결과

azelnidipine 8mg, 16mg

(인트로아젤니디핀정¹⁾ 8, 16밀리그램 등 10품목, (주인트로바이오파마 등 5개사)

☐ **제형, 성분·함량:**

- 1정 중 azelnidipine 8mg, 16mg

☐ **효능 효과:**

- 고혈압

☐ **약제급여평가위원회 심의일**

2022년 제8차 약제급여평가위원회: 2022년 8월 3~4일

- 약제급여기준 소위원회 심의일: 2022년 5월 27일

※ 약제급여평가위원회 평가결과 중 해당 제약회사의 영업상 비밀에 해당하는 내용(신청자의견, 신청가격 및 이와 관련된 투약비용, 재정영향 금액 등)은 공개대상에서 제외하였습니다.

가. 평가 결과

- ☐ 급여의 적정성이 있음
- 신청품은 “고혈압”에 허가받은 약제로 대체약제 대비 효과의 차이가 있다고 보기 어렵고, 소요비용이 대체약제보다 저렴하여 비용효과적이므로 급여의 적정성이 있음.
 - 8mg은 신청가가 약가협상생략기준금액(대체약제 가중평균가의 ■■■) 이하로 상한금액 협상절차를 생략하고, 16mg은 약가협상생략기준금액(대체약제 가중평균가의 ■■■, ■■■원) 이하를 수용할 경우 상한금액 협상절차를 생략할 수 있음.

나. 평가 내용

○ 진료상 필수 여부

- 신청품은 “고혈압”에 허가 받은 약제로, 현재 동일 적응증에 사용 가능한 약제로 동일 계열인 Dihydropyridine 계열의 칼슘채널차단제 경구제²⁾가 등재되어 있는 점 등을 고려 시, 약제의 요양급여대상여부 등의 평가기준 및 절차 등에 관한 규정 제6조(진료상 반드시 필요하다고 판단되는 약제)에 해당하지 않음.

○ 임상적 유용성

- 신청품은 “고혈압”에 허가된 약제로, 칼슘채널에 선택적으로 길항하여 혈관의 평활근세포 내 칼슘 유입 억제를 통해 혈관의 이완을 유도하여 혈압을 강하하는 3세대 장기 지속형 Dihydropyridine 계열의 칼슘채널차단제임.
- 신청품은 교과서³⁾ 및 임상진료지침⁴⁾에서 3세대 Dihydropyridine 계열의 칼슘채널차단제로 언급되고 있음.
- [Toshio Yamagishi]⁵⁾ 아침 혈압이 135/85mmHg 이상인 환자 108명을 대상으로 한 무작위 활성약 대조 공개 임상시험 결과,
 - 평균 아침 혈압 강하 수치는 azelnidipine 투여군(n=54)과 대조군(amlodipine 투여군, n=54)이 유의한 차이를 보이지 않았으며, 기상 후 측정된 맥박은 azelnidipine 투여군에서 유의한 감소를 보였음.
 - ✓ (평균 아침 혈압 강하 수치) azelnidipine 투여군: -24.1±11.8mmHg(수축기)/-14.1±10.7mmHg(이완기) vs amlodipine 투여군: -20.4±11.7mmHg(수축기)/-12.2±7.7mmHg(이완기)
 - ✓ (기상 후 측정된 맥박) azelnidipine 투여군: -6.4±8.3 회/분, P<0.001 vs amlodipine 투여군: -2.1±8.2 회/분, P=0.07
- [Xiuli Zhao, et al.]⁶⁾ 본태성 고혈압 환자 220명을 대상으로 한 무작위 활성약 대조 이중맹검 임상시험 결과,
 - 혈압 강하 수치는 azelnidipine 투여군(n=101)이 대조군(amlodipine 투여군, n=101)보다 컸으며, 맥박 감소는 두 군 간의 유의한 차이가 없었고, 이상 반응은 두 군 간의 유의미한 차이를 보이지 않았음.
 - ✓ (혈압 강하 수치) azelnidipine 투여군: -20.32±13.08mmHg(수축기)/-12.88±7.40mmHg(이완기) vs amlodipine 투여군: -14.98±14.62mmHg(수축기)/-9.79±8.00mmHg(이완기), P=0.005(수축기), P=0.003(이완기)
 - ✓ (맥박 감소) azelnidipine 투여군: 74.67(회/분) ± 6.55(기저치) → 73.57(회/분) ± 7.13(8주 투여 후) vs amlodipine 투여군: 74.26(회/분) ± 8.26(기저치) → 73.18(회/분) ± 7.05(8주 투여 후)

✓ 이상반응

- ☞ 전체 이상반응 발생: azelnidipine 투여군: 7.3% vs amlodipine 투여군: 10.0% (P=0.485)
- ☞ 두통: azelnidipine 투여군: 1.82% vs amlodipine 투여군: 4.55%
- ☞ 현기증: azelnidipine 투여군: 2.73% vs amlodipine 투여군: 2.73%

- 관련 학회에 따르면⁷⁾, 신청품은 효과의 발현속도가 느리고 오랫동안 작용하며 맥박에 영향이 적은 것이 특징이며, 기존 칼슘채널차단제들과 큰 차이는 없다는 의견임.

○ 비용 효과성

- 신청품의 허가사항, 교과서, 가이드라인, 급여기준, 학회의견 등을 고려하여 Dihydropyridine 계열의 칼슘채널차단제 경구제⁸⁾를 대체약제로 선정함.
- 신청품은 대체약제 대비 효과의 차이가 있다고 보기 어렵고, 신청품의 1일 소요비용(■원)은 대체약제 가중 1일 소요비용(■원) 대비 저렴하여 비용효과적임.
 - 대체약제 가중평균가로 환산한 신청품의 단위비용은 8mg: ■원/정, 16mg: ■원/정임.
 - 신청품의 약가협상생략기준금액⁹⁾은 8mg: ■원/정, 16mg: ■원/정임.

○ 재정 영향¹⁰⁾

- 신청약가 기준
 - 해당 적응증의 대상 환자수는 약 ■만명¹¹⁾이며, 제약사 제출 예상사용량¹²⁾을 기준으로 신청품의 도입 후 절대재정소요금액¹³⁾은 1차년도 약 ■억원, 3차년도 약 ■억원이고, 대체약제의 대체로 인한 재정증분은 없음.

※ 신청품의 대상 환자수, 투여기간, 시장점유율 등에 따라 재정영향은 변동될 수 있음.

○ 제외국 약가집 수재 현황

- 신청품은 A7 국가 중 1개국(일본)의 약가집에 수재되어 있음.

References

- 1) 논의 후에 품명이 ‘인트로아젤니디핀정8, 16밀리그램’에서 ‘아젤블럭정8, 16밀리그램’으로 변경되었고, 기존 (주)팜젠사이언스의 ‘젤라디핀정8, 16밀리그램’에서 품목 양도양수를 통해 (주)한국파마의 ‘아제리아정8, 16밀리그램’으로 변경됨
- 2) amlodipine adipate, amlodipine besylate, amlodipine camsylate, amlodipine maleate, amlodipine mesylate monohydrate, amlodipine nicotinate, amlodipine orotate, S-amlodipine besylate, S-amlodipine nicotinate, barnidipine hydrochloride, benidipine hydrochloride, cilnidipine, efonidipine, felodipine, lacidipine, lercanidipine hydrochloride, manidipine hydrochloride, nicardipine hydrochloride, nifedipine, nifedipine(micronized), nisoldipine
- 3) Hypertension A Companion to Braunwald’s Heart Disease. 3e. 2018.
- 4) The Japanese Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension. 2019
- 5) Toshio Yamagishi. Efficacy of Azelnidipine on Home Blood Pressure and Pulse Rate in Patients with Essential Hypertension: Comparison with Amlodipine. Hypertension research, 2006, 29.10: 767-773.
- 6) Xiuli Zhao, et al. Azelnidipine and Amlodipine: A Comparison of Their Effects and Safety in a Randomized Double-Blinded Clinical Trial in Chinese Essential Hypertensive Patients. Clinical and Experimental Hypertension, 32(6): 372 - 376, (2010).
- 7) 대한고혈압학회()
- 8) amlodipine adipate, amlodipine besylate, amlodipine camsylate, amlodipine maleate, amlodipine mesylate monohydrate, amlodipine nicotinate, amlodipine orotate, S-amlodipine besylate, S-amlodipine nicotinate, barnidipine hydrochloride, benidipine hydrochloride, cilnidipine, efonidipine, felodipine, lacidipine, lercanidipine hydrochloride, manidipine hydrochloride, nicardipine hydrochloride, nifedipine, nifedipine(micronized), nisoldipine
- 9) 신청품은 기존 계열의 약제로 국민건강보험 요양급여의 기준에 관한 규칙 제11조의2제1항제4호 및 약제의 결정 및 조정 기준 제7조제7항에 따라, 약가협상생략기준금액은 대체약제의 가중평균 금액(신청약제의 단위 비용으로 환산된 금액)의 % 금액임.
- 10) 동 재정소요금액은 요양급여비용의 총액임(보험자 및 환자 부담금의 합)
- 11) 2019-2021년 청구자료 중 수진자 연령 19세 이상이면서 상병코드 I10(본태성 고혈압), I11(고혈압성 심장병), I12(고혈압성 신장병), I15(이차성 고혈압)으로 amlodipine besylate, amlodipine maleate, amlodipine camsylate, amlodipine adipate, amlodipine mesylate monohydrate, amlodipine orotate, amlodipine nicotinate, S-amlodipine besylate, S-amlodipine nicotinate, barnidipine hydrochloride, benidipine hydrochloride, cilnidipine, felodipine, lacidipine, lercanidipine hydrochloride, manidipine hydrochloride, nicardipine hydrochloride, nifedipine, nisoldipine, efonidipine, nifedipine(micronized) 경구제를 처방받은 환자 수에서 연평균성장률(0.69%, CAGR)을 산출하여 당해연도(2022년) 기준 대상 환자 수를 산출함.
- 12) 5개 제약사에서 모두 예상 사용량: 1차년도 8mg-정, 16mg-정, 3차년도 8mg-정, 16mg-정으로 동일하게 제출함.
- 13) 절대재정 소요금액 = 제약사 제출 예상 사용량 × 제약사 신청가